

BILET DE IESIRE / SCRISOARE MEDICALA

Nr. contract/conventie:
VII/SP/22

FO: **16628**

Nume: IONESCU MARIA	Domiciliu: Loc.Timisoara	Data internare: 23/04/2026 10:06
C.N.P: 2500315350019	Jud: Timis	Data externare: 23/04/2026 14:21
Data nastere: 15/03/1950	Strada: Str. Revolutiei	Sectia: ONCOLOGIE
Varsta: 76 Sex: F	Nr: 12	Medic: Dr. Popescu Andrei
Grup sangvin: A RH: +	Alergii: NU CUNOASTE	

Diagnostic: Melanom malign cutanat braf mutant pt2n0(0+/3 GS)m0 braf mutant st. I B op., tratat adjuvant cu IFN alfa (2010). det sec subcutanate, osoase, hepatice. imunoterapie nivolumab + ipilimumab x 4 cu Remisiune completa, apoi Nivolumab de intretinere. Hipofizita autoimuna G1.

Investigatii efectuate:

Buletin 23/04/2026 :

Hemoleucograma completa: [(WBC) Leucocite=5.79 10⁹/L, Neutrofile %=56.7 %, Monocite %=7.8 %, Eosinofile %=10.0 %, Basofile %=1.3 %, Limfocite %=24.2 %, Neutrofile #=3.28 10⁹/L, Monocite #=0.45 10⁹/L, Eosinofile #=0.58 10⁹/L, Basofile #=0.08 10⁹/L, Limfocite #=1.40 10⁹/L, (RBC) Hematii=4.28 10¹²/L, (HGB) Hemoglobina=12.9 g/dL, (HCT) Hematocrit=38.2 %, (MCV) Volum mediu eritrocitar=89.3 fL, (MCH) Hemoglobina eritrocitara medie=30.1 pg, (MCHC) Concentr. medie de hemoglob. eritrocitara=33.8 g/dL, *(RDW-CV) Coef de variatie al indicelui de distributie al eritrocitelor=12.7 %, (RDW-SD) Indice de distributie a eritrocitelor=41.8 fL, (PLT) Trombocite=155 10⁹/L, (PDW) Indice de distributie a trombocitelor=17.1 fL, (MPV) Volum mediu trombocitar=12.1 fL, *(PCT) Placetocrit=0.188 %, *IMG%=0.1 %, *IMG#=0.01]
Bilirubina totala=0.626 mg/dL, Calciu seric total=9.31 mg/dL, Creatinina serica=0.58 mg/dL, Fosfataza alcalina=52.82 U/L, Glicemie=109.57 mg/dL, Potasiu seric=3.47 mmol/L, Sodiu seric=144 mmol/L, TGO/AST=22.34 UI/l, TGP/ALT=10.57 UI/l

Tratament:

Ciclul: 38

Acronim: Nivo q4w

Grupa sange | RH:

Tip

Nr pungii

Data

Epicriza: Pacienta in varsta de 76 de ani, diagnosticata in 2010 cu Melanom malign cutanat Breslow=1,5 mm (interscapulovertebral) op. pT2N0(0+/3 GS) M0 std I B, tratat cu adjuvant cu IFN timp de 2 luni (si intrerupt datorita toxicitatii), prezinta dupa un interval liber de aprox. 12 ani, in martie 2023, det. sec. cutanate, una fiind excizata, cu rezultatul HP : Det. sec de melanon malign, se prezinta pentru continuarea imunoterapiei. S-a analizat mutatia BRAF cu rezultatul: BRAF in exonul 15 s-a detectat mutatia activatoare BRAF V600E.
PET CT (26.05.2023 - Medima): Concluzii: Multiple fixari focale FDG diseminate la

nivel cutanat, limfo-ganglionar, osos si hepatic - inalt sugestive pentru det sec. RMN cerebral- M0.

In cadrul CDIT se decide tratament cu Ipilimumab + Nivolumab x 4, cu reevaluare imagistica la 3 luni.

CT TAP (Oncohelp 01.09.2023): Pacienta in observatie oncologica pentru melanom malign operat, imunotratat. Lipsa iconografie anterioara. Modificari pulmonare in context inflamator/infectios la nivelul LMD, segmentelor latero- si posterobazal LID, segmente bazale LIS. Nodul pulmonar de 0.5 cm- segment anterior LSD. Adenopatii mediastinale. Noduli tisulari la nivelul partilor moi subtegumentar regiune retroscapulara stanga. Nodul tisular bine delimitat de 0.85 cm- mamar extern stanga.

Biologic: Cortizol seric (29.08.2023): 14.6 mmol, FT4 = 0,465 ng/dl, in rest HLB, probe renale, hepatice=N.

PET CT: - remisiune completa.

CT TAP (Medima): boala stationara.

19.04.2024 TSH=3,4210 mUI/L; FT4=1.00 ng/dl; cortizol seric= 0,46 ng/dl, DHEA-S=6,5 ug/dl;

CT Craniu 08.07.2024 - Medima): Imagine nodulara lacara, localizata cortical, la nivelul girusului F mijlociu stg - leziune sechelara - similar. Meningiom calcifiat F stang similar. Mica lacuna ischemica la nivelul hipocampului drept.

CT TAP (08.07.2024): Limfonoduli mediastinali - in regresie numerica si dimensionala. Litiaza veziculara. Cisturi corticale renale bilateral. Cate o imagine osteocondensanta, bine delimitata, localizata la nivelul corpurilor vertebrale T5, T8, T10, similare - necesita monitorizare. Hernii Bochdalek. Glanda tiroida cu structura neomogena prin prezenta la nivelul LTS a 3 imagini nodulare hipodense - cvasisimilar cu examinarea anterioara - necesita corelare cu ecografia.

CT TAP (24.10.2024; Medima): Boala stationara.

CT TAP(28.01.2025, Medima): Boala stationara.

CT TAP(18.08.2025, Medima): Boala stationara.

CT TAP(17.02.2026, Medima): Boala stationara.

Actual, se prezinta pentru continuarea imunoterapiei

Clinic: IP= 0 ECOG, mentine RC.

Lab.- in limite normale

Se administreaza Nivolumab C38 in doze optimele (Nivolumab 480 mg DT), cu toleranta acuta buna.

Recomandari: Se externeaza cu indicatiile:
! Pacientei i s-a emis brosură/card cu posibilele reactii adverse si tratamentul acestora;
-Repeta CT TAP in august 2026
-Revine pentru continuarea tratamentului in data de 21.05.2026.

Sunteti programat in data: 21 Mai 2026 ora: 09:10

Indicatie de revenire pentru internare:

- ☒ da, revine pentru internare in termen de 4 saptamani
- ☐ nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicala, caz in care se va inscrie seria si numarul acesteia
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz in care se va inscrie seria si
numarul acestuia
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la
domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îndrijiri medicale la domiciliu/paliative la
domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
deoarece nu a fost necesar

**Pentru programari sunati la urmatoarele numere: fix , mobil in programul in zilele
lucratoare sau transmiteti un e-mail la cu precizarea numarului de telefon de
contact.**

Pentru urgente sunati la 112 sau va prezentati la cel mai apropiat centru de primiri urgente.

Medic curant
Semnatura, parafa

Calea de transmitere:

- X - prin asigurat
- prin posta

.....

Semnatura pacient:
.....